

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **bioética** es la disciplina que reflexiona sobre los dilemas morales que surgen de la práctica médica, la investigación y las políticas de salud. Su propósito es asegurar que las decisiones en salud se orienten por los valores de **dignidad, respeto, equidad y responsabilidad social**.

En el contexto de la **salud pública**, la bioética trasciende la relación médico–paciente y se extiende al ámbito colectivo: distribución de recursos, priorización de intervenciones, y decisiones en contextos de escasez o emergencia.

Por su parte, la **justicia sanitaria** busca garantizar que todas las personas tengan acceso equitativo a los **determinantes sociales de la salud**, a los servicios y a los beneficios de la ciencia médica.

En el **EUNACOM**, este tema es transversal: el médico general debe comprender los **principios bioéticos universales** y aplicarlos tanto en la atención individual como en la toma de decisiones comunitarias, especialmente en el marco del **Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria (MAIS)**.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Definición de bioética

El término fue acuñado por **Van Rensselaer Potter (1970)**, quien la definió como un “puente hacia el futuro” entre las ciencias biológicas y los valores humanos.

Actualmente, la **OMS (2023)** la describe como:

“La aplicación sistemática de los principios éticos a la medicina, la investigación, la salud pública y las políticas sanitarias.”

2.2. Principios fundamentales de la bioética

El **Informe Belmont (1979)** y la **Declaración de Helsinki (WMA, 2013)** establecieron los principios básicos, posteriormente ampliados por Beauchamp y Childress en su modelo de los **Cuatro Principios**:

Principio	Descripción	Aplicación en salud pública
Autonomía	Derecho de cada persona a decidir libremente sobre su cuerpo y su salud.	Consentimiento informado, participación comunitaria.
Beneficencia	Promover el bienestar del paciente y la comunidad.	Programas preventivos y promoción de salud.
No maleficencia	Evitar daño físico, psicológico o social.	Seguridad en intervenciones, control de efectos adversos.
Justicia	Distribución equitativa de los beneficios y cargas sanitarias.	Acceso igualitario a servicios y recursos.

2.3. Bioética clínica vs. bioética pública

Dimensión	Bioética clínica	Bioética pública
Enfoque	Relación médico–paciente	Salud colectiva y políticas sanitarias
Escenario típico	Hospital, consulta, urgencias	Programas nacionales, vacunación, recursos escasos
Pregunta central	¿Qué es lo mejor para este paciente?	¿Qué es justo para la población?
Ejemplo	Consentimiento para cirugía	Prioridad de vacunas en pandemia

La **bioética pública** enfatiza el equilibrio entre el **bien común y los derechos individuales**, especialmente en situaciones de emergencia sanitaria o inequidad estructural.

3. La justicia sanitaria

3.1. Definición y fundamentos

La **justicia sanitaria** se refiere a la distribución equitativa de los **recursos, oportunidades y servicios** que permiten alcanzar el más alto nivel posible de salud.

La **OMS (Carta de Ottawa, 1986)** sostiene que la salud es un **derecho humano fundamental** y que la equidad es una condición esencial para alcanzarlo.

3.2. Tipos de justicia

Tipo	Concepto	Ejemplo
Justicia distributiva	Asignación equitativa de recursos.	Distribución de camas UCI durante pandemia.
Justicia procedimental	Transparencia en la toma de decisiones.	Comité ético que prioriza trasplantes.
Justicia restaurativa	Reparación de daños sanitarios o ambientales.	Compensación por negligencia médica.
Justicia intergeneracional	Responsabilidad con generaciones futuras.	Políticas de cambio climático y salud.

4. Bioética aplicada en políticas públicas

En salud pública, las decisiones deben considerar el impacto poblacional, la eficiencia de los recursos y la equidad social.

4.1. Ejemplos prácticos de dilemas éticos colectivos

Contexto	Dilema ético	Criterio bioético aplicado
----------	--------------	----------------------------

Pandemia COVID-19	Asignación de ventiladores mecánicos	Justicia distributiva y principio de necesidad
Vacunación obligatoria	Autonomía vs. bien común	Principio de proporcionalidad
Programa GES (AUGE)	Selección de patologías prioritarias	Principio de equidad y costo-efectividad
Investigación en salud comunitaria	Uso de datos sensibles	Consentimiento colectivo y confidencialidad
Cambio climático y salud	Impacto desigual en grupos vulnerables	Justicia ambiental

4.2. Marco normativo chileno

Documento	Institución	Contenido
Ley 20.584 (2012)	MINSAL	Derechos y deberes de las personas en salud.
Ley 20.120 (2006)	Congreso Nacional	Ética en investigación biomédica.
Código Sanitario (DS 725/1967)	Ministerio de Salud	Normas generales de atención y bioseguridad.
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005)	Naciones Unidas	Enfatiza justicia, solidaridad y respeto cultural.

5. Ética de la equidad y vulnerabilidad

La bioética moderna reconoce que **no todos los individuos parten desde el mismo punto**, y que los grupos vulnerables requieren **protección reforzada**.

5.1. Poblaciones en situación de vulnerabilidad:

- Niños, adultos mayores, personas con discapacidad.
- Pueblos originarios y comunidades rurales aisladas.
- Migrantes y refugiados.
- Personas privadas de libertad.
- Grupos en pobreza extrema o exclusión social.

5.2. Enfoque de justicia sanitaria en Chile

- **Estrategia Nacional de Salud 2030:** busca reducir brechas de mortalidad y morbilidad según nivel socioeconómico.
 - **Modelo de Atención Integral en Salud Familiar (MAIS):** prioriza grupos vulnerables.
 - **Política Nacional de Salud de Migrantes (2017):** acceso universal sin discriminación.
-

6. Bioética y salud ambiental

El enfoque contemporáneo de bioética incorpora el principio “**One Health**” (**Una Salud**), que integra salud humana, animal y ambiental.

Principios claves:

- Responsabilidad ecológica: evitar daños ambientales que afecten la salud humana.
- Precaución: ante incertidumbre científica, optar por medidas que minimicen riesgos.
- Justicia intergeneracional: preservar los recursos naturales para las futuras generaciones.

Ejemplo: políticas sobre contaminación atmosférica, residuos hospitalarios o energía sostenible.

7. Rol del médico general en bioética y justicia sanitaria

Rol	Descripción	Ejemplo
Garante ético en APS	Aplica principios bioéticos en decisiones clínicas y comunitarias.	Derivación justa en lista de espera GES.
Agente de equidad	Promueve acceso igualitario a la atención.	Priorización de pacientes vulnerables.
Educador comunitario	Difunde derechos y responsabilidades en salud.	Talleres sobre ética y autocuidado.
Colaborador en comités de ética	Participa en revisión de casos y políticas.	Comité ético local o regional.
Defensor de justicia sanitaria	Denuncia desigualdades o abusos.	Reporte de negación de atención injustificada.

8. Errores comunes en EUNACOM

Error frecuente	Corrección conceptual
-----------------	-----------------------

Pensar que la bioética solo se aplica en investigación o hospitales.

La bioética también guía la salud pública y comunitaria.

Creer que la justicia sanitaria es solo redistributiva.

Incluye justicia procedimental, ambiental e intergeneracional.

Confundir autonomía con decisión sin límites.

La autonomía se equilibra con el bien común y la seguridad pública.

Ignorar vulnerabilidad social en decisiones médicas.

Los grupos vulnerables requieren prioridad y apoyo ético.

Pensar que equidad y igualdad son sinónimos.

La equidad ajusta los recursos según las necesidades, no los iguala.

9. Complicaciones y desafíos éticos contemporáneos

1. **Escasez de recursos sanitarios** en crisis económicas o desastres.
2. **Tensión entre libertad individual y salud pública** (ej. vacunas, cuarentenas).
3. **Uso de inteligencia artificial** y algoritmos en diagnóstico médico: sesgos y justicia algorítmica.
4. **Impacto del cambio climático** sobre poblaciones pobres y rurales.
5. **Privatización y desigualdad en el acceso a salud.**

El desafío es equilibrar **eficiencia, equidad y sostenibilidad**, manteniendo los valores éticos universales.

10. Referencias ministeriales y técnicas

- Ley 20.584 (2012). Derechos y deberes de los pacientes.
 - MINSAL (2021). Estrategia Nacional de Salud 2030.
 - UNESCO (2005). Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.
 - OPS/OMS (2023). Bioética y equidad en salud pública.
 - Comité Nacional de Bioética (Chile, 2021). Guía de Ética Clínica y Sanitaria.
 - Van R. Potter (1971). Bioethics: Bridge to the Future.
-

11. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. La **bioética** integra ciencia y valores para orientar las decisiones en salud, investigación y políticas públicas.
2. Los **cuatro principios básicos** —autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia— son universales y aplicables tanto al nivel clínico como poblacional.
3. La **justicia sanitaria** exige equidad en el acceso, distribución y calidad de los servicios de salud.
4. El **médico general** debe ser un garante ético, promotor de derechos y defensor de la equidad sanitaria.
5. Las **políticas públicas chilenas** incorporan el enfoque ético mediante el MAIS y la Estrategia Nacional de Salud 2030.
6. La bioética moderna incluye la **justicia ambiental e intergeneracional**, frente a desafíos globales como el cambio climático.
7. En el contexto EUNACOM, dominar estos principios permite responder correctamente a dilemas éticos reales en atención primaria y salud pública.